

Responsabilità

Qualifica	Nome	Firma
Direttore Generale	Avv. G. Zanetta	
Direttore Sanitario	Dott. C. Plazzotta	
Altri (ad es responsabile Qualità, Direttori di Dipartimento o di SC, Dirigente SITRA)		
Direttore	Dr. Zanetta	
Coordinatore GIC aziendale	Dr. Eugenio Zanon	
Referente Aziendale per la Rete Oncologica	Dott. C. Plazzotta	
Direttore Dipartimento Rete Oncologia Piemonte e valle d'Aosta	Prof. Massimo Aglietta Dott. Mario Airolti Dott. Alessandro Comandone	

Data di approvazione	10/11/2025
Periodicità di revisione	triennale
Data prossima revisione	Novembre 2026
Modalità di diffusione interna	<i>Copia cartacea presso la Direzione Sanitaria, Intranet aziendale, Presentazione nelle riunioni mensili del GIC</i>
Copia cartacea presso la Direzione Dipartimento Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta	

Composizione GIC

Indicare con * le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo regolare

Strutture	Referente	Componenti	Firma
<i>Senologia Diagnostica</i>	Dr. E. Zanon		
		Dr.ssa I. Abiuso	
		Dr.ssa C. Bertaggia	
		Dr. D. Bosco	
		Dr.ssa F. Gunetti	
		Dr.ssa F. Angelino	
		Dr.ssa S. Martinello	
		Dr.ssa A. Milan	

Strutture	Referente	Componenti	Firma
		Dr.ssa V. Miseroocchi	
<i>Anatomia Patologica</i>	Dr.ssa L. Macri'	Dr.ssa L. Bianchi Malandrone	
<i>Chirurgia Senologica</i>	Dr. R. Bussone		
		Dr.ssa G. Grilz	
		Dr.ssa A. Cicako	
		Dr.ssa A. Ruggieri	
		Dr.ssa M. Scamuzzi	
<i>Riabilitazione</i>	Dr.ssa G. De Pace		
<i>Oncologia</i>	Dr.ssa M. Minischetti		
		Dr. C.A. Raucci	
		Dr. A. Gerbino	
<i>Radioterapia</i>	Dr.ssa C Mantovani	Dr.ssa C Mantovani	
		Dr.ssa C. Casali	
		Dr.ssa F.Arcadipane	
<i>Psicooncologia*</i>	Dr.ssa S. Di Paola		
<i>Cure Palliative*</i>	Dr. F. Garetto		
<i>Assistente Sociale*</i>	Dr. R. Bertolusso		
<i>Nutrizionista*</i>	Dr. A. Demagistris		
Coordinatore Infermieristico	Inf. G.Bena		
Infermiere GIC		Inf. S.E. Perrone	
		Inf. R. Bernardi	
		Inf. M. Machetta	
		Inf. T. Romano	
Amministrativo CAS	Sig.ra L.Loiotile , Sig.ra I. Imparato, Sig.ra A Masetti		
Amministrativo Ambulatorio Terapie / DH Oncologia	Sig.ra L.Loiotile , Sig.ra I. Imparato, Sig.ra A Masetti		

GIC - regolamento

Coordinatore	Dr. Eugenio Zanon, Senologia Diagnostica, eugenio.zanon@gmail.com
Segreteria	CAS – primo piano tel 011 5294561
Sede dell'incontro	Sala Riunioni, IV piano – Direzione Sanitaria Ospedale Cottolengo
Periodicità dell'incontro e orario	Settimanale: mercoledì' h 9.00 – 12.00
Modalità di refertazione	Verbale, software aziendale Log80
Descrizione sintetica del funzionamento	Tutti i pazienti con diagnosi sospetta o certa di neoplasia mammaria, esito di biopsia e sottoposti a visita CAS (solitamente chirurgica senologica, in casi selezionati oncologica) vengono discussi in GIC PRE-TERAPIA (solitamente GIC PRE-OPERATORIO) Tutti i pazienti sottoposti a chirurgia senologica e con esito di esame istologico operatorio vengono discussi in GIC POST-OPERATORIO Casi multidisciplinari complessi (tumori localmente avanzati o in ricaduta locale / sistemica) vengono inviati al GIC su indicazione specialistica in spazi dedicati prenotabili dal CAS La refertazione delle indicazioni del GIC avviene in LOG80 per tutti i casi a partire dalle bozze di presa in carico infermieristica, visita CAS e precedente GIC.
Descrizione del percorso assistenziale	In caso di elevato sospetto clinico o radiologico, in ottemperanza al documento di consenso della Rete Oncologica (esame clinico altamente sospetto, mastite carcinomatosa, infiltrazione/ulcerazione cutanea, fissità retrazione cutanea ed erosione del capezzolo, quadro radiologico R4 R5 / U4 / U5), al momento della diagnosi radiologica, il Radiologo Senologo e la Segreteria della Senologia Diagnostica compilano il modulo esenzione 048T e avviano la prenotazione dell'agobiopsia. Una copia del modulo di esenzione viene inviata al CAS. Alla consegna dell'esame istologico in corso di biopsia il Radiologo Senologo e la Segreteria della Senologia Diagnostica indicano eventuali ulteriori esami diagnostici (es.: RM mammaria con mdc), consegnano il modulo di esenzione 048 (se non fatto prima) e inviano la Paziente al CAS e alla Presa in Carico Infermieristica, con prenotazione di Visita CAS. Viene pertanto allestita una Cartella CAS che seguirà la Paziente nell'intero percorso. Le Infermiere CAS/GIC in parallelo alla Amministrativa del CAS accolgono il pz, verificano l'esenzione 048, raccolgono la documentazione relativa agli esami effettuati, organizzano la visita CAS e il successivo GIC pre-operatorio o più genericamente GIC pre-terapia. La presa in carico infermieristica assume un ruolo particolarmente rilevante e si sviluppa lungo l'intero percorso diagnostico-terapeutico della donna. L'infermiera di senologia, è una figura di riferimento costante e funge da ponte tra la paziente e il team multidisciplinare. Questa figura professionale assicura la continuità assistenziale, favorisce la comunicazione efficace tra i diversi attori del percorso di cura e traduce le informazioni cliniche in modo

	chiaro e comprensibile per la paziente. L'infermiere di senologia: • accoglie la persona e la orienta nel percorso diagnostico (mammografia, ecografia, biopsie, visite chirurgiche ecc.); • la sostiene nel momento delicato della comunicazione della diagnosi, offrendo supporto emotivo e informazioni pratiche; • attraverso un colloquio dedicato, l'infermiera effettua la presa in carico infermieristica; • accompagna la paziente durante tutte le fasi di trattamento sia chirurgico sia medico; • promuove l'autonomia e l'empowerment della donna attraverso l'educazione; • garantisce una continuità, anche nel lungo periodo, monitorando i bisogni assistenziali e psicologici residui. Già in fase diagnostica o comunque alla visita CAS / GIC viene posta indicazione a Counselling genetico secondo le LG AIOM 2023. In questi casi il medico in visita consegna alla persona assistita il modulo di raccolta anamnestica (anamnesi familiare oncologica), il modulo di consenso informato, il promemoria per l'esecuzione del test genetico e la richiesta medica che la paziente presenterà al laboratorio analisi dell'Ospedale S. Anna il giorno dell'esame. L'accesso per il test genetico è diretto. Il medico specialista può inoltre inviare la paziente a consulenza genetica in relazione alla storia clinica. In casi selezionati può essere avviata da uno specialista partecipante al GIC una richiesta alla Genetica Universitaria con canale di urgenza ad esempio specificando la tempistica della chirurgia prevista. In alternativa il paziente può essere avviato fuori regione o su richiesta a canali alternativi. All'arrivo del test genetico la paziente sarà convocata in visita chirurgica per la consegna del test e per il proseguo delle cure. O in visita Oncologica se il paziente è in carico al DH per terapie mediche Il Chirurgo Senologo nella Visita CAS effettua una valutazione preliminare sul tipo di intervento, in caso di intervento demolitivo illustra le modalità ricostruttive e la successiva valutazione chirurgo-plastica, richiede eventuali esami stadiali nello stadio II e III (o in caso di carcinoma della mammella in ricaduta locale) e avvia il paziente al consulto multidisciplinare GIC PRE-OPERATORIO Al termine della fase diagnostica, sulla scorta degli esiti degli accertamenti effettuati, il pz viene indirizzato nel percorso adeguato al proprio stadio di malattia La Presa in Carico Infermieristica avviene secondo le modalità operative e le schede di valutazione infermieristica indicate dalla Rete Oncologica, al momento del primo accesso del paziente al CAS o comunque entro la prima visita GIC, al fine di individuare le problematiche assistenziali presenti (presenza di malnutrizione, dolore, problematiche psicosociali- presenza di fragilità-
--	--

	presenza/necessità CVC – problematiche specifiche, compilazione G8 per i pazienti di età >75 aa, segnalazione per progetto protezione famiglie fragili). L'infermiere GIC segue gli aspetti organizzativi mantenendo il contatto con le diverse equipe assistenziali coinvolte e si occupa degli aspetti educativi previsti dal percorso Per il carcinoma della mammella operabile i pazienti con GIC PRE con indicazione ad intervento vengono inserite in waiting list e progressivamente contattati per prericovero, al fine di ottenere l'idoneità anestesiologica e per l'acquisizione dei consensi informati Nei casi di TUMORI INFILTRANTI potenzialmente candidabili a trattamento neoadiuvante (secondo il Documento di Consenso della Rete Oncologica 2018): TUMORI OPERABILI CON PAZIENTE CANDIDATA ALLA MASTECTOMIA per rapporto sfavorevole tra dimensione del tumore e dimensioni della mammella. TUMORI INFILTRANTI di dimensioni >2 cm . TUMORI CON STATO LINFONODALE N+ soprattutto se NST e di grado intermedio / elevato al fine di valutare un trattamento neoadiuvante per ridurre il carico tumorale e consentire un down staging chirurgico già in fase diagnostica radiologica oltre che in corso di visita CAS sarà avviata definizione del fenotipo con richiesta dei fattori prognostici e predittivi sulla biopsia In particolare nei TUMORI INFILTRANTI TRIPLO NEGATIVI E HER2 POSITIVI l'obiettivo è selezionare le pazienti per le quali l'efficacia clinica del trattamento neoadiuvante (risposta clinica e risposta patologica) siano massimali . Al contrario individuare pazienti a prognosi peggiore resistenti o meno responsive, con residuo di malattia dopo CT neoadiuvante, eleggibili a ulteriori trattamenti adiuvanti (diversi da quelli utilizzati in fase neoadiuvante) standard o sperimentali. Per il carcinoma localmente avanzato non operabile TUMORI LOCALMENTE AVANZATI NON OPERABILI stadio IIIB IIIC - CARCINOMA INFIAMMATORIO E MASTITE CARCINOMATOSA Come per i casi suddetti viene avviata tipizzazione biologica in fase diagnostica o in corso di visita CAS. Alla successiva discussione GIC PRE-TERAPIA sarà confermata l'indicazione a terapia sistemica rispettivamente NEOADIUVANTE E PRIMARIA (Chemioterapia CT, chemioimmunoterapia o chemioterapia e terapie biologiche) e la persona assistita avviata a stadiazione e Visita Oncologica per programmazione/avvio trattamento (PDTA DEDICATO lo inserirò qui). Uguualmente viene avviata a Visita Oncologica la persona assistita che agli esami diagnostici stadiali risulti portatrice di secondarietà o che recidivi successivamente a distanza (Carcinoma della mammella in fase avanzata metastatica). Anche in questo caso peraltro, a seconda della sede (metastasi cutanee, linfonodali, polmonari, epatiche, cerebrali, ossee) e del numero delle secondarietà saranno discusse in ambito GIC in spazi dedicati
--	--

	prenotabili dal CAS, l'indicazione a trattamento locoregionale (asportazione delle recidiva; radioterapia; elettrochemioterapia) in associazione o con modalità sequenziale al trattamento sistemico (chemioterapia, endocrinoterapia, terapia biologica) Nell'immediato post-operatorio i pazienti sottoposti a mastectomia (con / senza ricostruzione) e/o dissezione ascellare vengono inviati alla riabilitazione su segnalazione dei chirurghi senologi. Al contrario tale invio potrà avvenire anche successivamente e in casi sottoposti a chirurgia conservativa, in occasione di complicanze fisiatriche, su segnalazione di un qualunque specialista del GIC Per i pazienti sottoposti a chirurgia, l'infermiere GIC all'arrivo dell'esame istologico inserisce il caso nella discussione GIC POST-OPERATORIA, nella quale viene posta indicazione a eventuale reintervento (es.: allargamento dei margini, dissezione ascellare) e ai trattamenti adiuvanti sistemici e locali, in tutti i casi nel rispetto delle LG AIOM 2019 e delle Raccomandazioni / Documenti di Consenso della Rete Oncologica L'amministrativo CAS contatta i pazienti inseriti nel GIC POST per visita di ritiro istologico. Tale visita viene effettuata al termine del GIC (mercoledì h 12 – 16) dallo Specialista Oncologo +/- con lo Specialista Radioterapista nell'Ambulatorio Oncologia - secondo piano – I pazienti candidati a terapie mediche ricevono al momento della consegna del referto GIC preoperatorio (per le CT neoadiuvanti o malattia avanzata) o postoperatorio (per le adiuvanti) da parte dell'Oncologo partecipante al GIC che consegna referto della collegiale, una spiegazione sulle motivazioni della proposta di cura evidenziando finalità, modalità, effetti collaterali e rischi complicanze dei trattamenti proposti. Per chemioterapia o terapie ormonali complesse (es con inibitori ciclina) viene esposta e fornita una informativa personalizzata che viene inclusa nel referto GIC. In tale sede vengono anche richiesti gli accertamenti propedeutici alla prosecuzione del percorso di cura (es ECG, Ecocardio, TC di stadiazione con raccolta di scheda anamnestica-allergologica, posizionamento CVC, etc) Tali accertamenti vengono prenotati dalla Segreteria DH-CAS dopo avere ricevuto le apposite impegnative mutualistiche. In tale sede viene anche compilata una cartellina che contiene consenso alla privacy e copia referto GIC) e su cui vengono annotati gli accertamenti previste e la terapia proposta. Nel caso di indicazione a CT questa viene già prescritta la CT su LOG80 al fine di occupare un posto in tempi adeguati e in modo che gli amministrativi sappiano entro quale tempo concludere gli accertamenti propedeutici. Sempre in questa fase il Medico Oncologo fornisce informazioni sulla logistica ed il funzionamento del DH ambulatorio terapie antitumorali. Il paziente viene congedato con referto GIC, appuntamento orientativo per la terapia e modulo con elenco impegnative da compilare da parte del MMG con indirizzo mail cui inviarle Congedato il paziente il medico compila quando indicato scheda
--	---

	AIFA per elegibilità e prescrizione e ne invia copia al Settore Farmaci. Per i pazienti candidati a terapia ormonale vien data indicazione ad eseguire ECO TV e DXA lombare e femorale con supplementazione calcio e vitD in caso di Tamoxifene ed antiaromatasiico rispettivamente. Nel caso in cui la storia clinica lo consenta al terapia ormonale viene prescritta alla consegna del referto GIC e confermata alla prima visita oncologica che viene prenotata dal CAS. In caso di indicazione a CT e ET di I linea invece il personale amministrativo recuperate impegnative e consensi prenotata gli accertamenti previsti e fissa al termine appuntamento per prima visita oncologica nei giorni precedenti all'accesso per CT. Alla prima visita oncologica il medico analizza e trascrive nella cartella elettronica gli accertamenti propedeutici e conferma indicazione al trattamento. Si accerta che il paziente abbia recepito le informazioni date al precedente incontro e raccoglie consenso alla CT. Il medico fornisce anche un elenco di farmaci ancillari alla CT, in premedicazione o al domicilio dopo il trattamento come le terapie da assumere al bisogno in relazione a vari sintomi che si possono presentare. In tale sede viene altresì rilasciato un modulo per richiedere rimborso per parrucca in caso di terapie alopecizzante e esenzione parcheggio GTT Per la prescrizione delle terapie oncologiche in fase adiuvante ed avanzata la SC di Oncologia fa riferimento alle linee guida AIOM 2023 ed ESMO 2024 e 2025 e osserva glischemi e le indicazioni condivise con il Servizio Farmaceutico ASL Città di Torino Il paziente dovrà essere invitato a svolgere regolare attività fisica e a seguire consigli Alimentari secondo le Raccomandazioni OMS /WCRF. Sarà inviato a counselling nutrizionistico nel caso di BMI ≥ 24 e rapporto peso corporeo / altezza >0.50, o ancora in caso di sindrome metabolica Modalità accesso per trattamenti oncologici presso DH ambulatorio SC Oncologia. Il paziente dopo avere effettuato la prima visita oncologica con conferma prescrizione piano terapeutico, ha un appuntamento per accedere al DH ed effettuare la terapia. Successivamente alla prima visita oncologica il paziente viene presentato agli infermieri del DH Oncologico che descrivono al paziente gli step e il percorso per la somministrazione della terapia. L'organizzazione per il paziente nel DH avviene nel seguente modalità: il paziente entra in DH alle ore otto della mattina per effettuare prelievi e rilevazione dei parametri. Successivamente il paziente viene chiamato nell'ambulatorio del medico.
--	---

	Il medico procede con la visita e raccoglie l'anamnesi prossima o relativa alla somministrazione della precedente terapia, registra eventuali tossicità verifica l'ematochimici, visita il paziente, verificata l'idoneità e conferma o rinvia la terapia, oppure in base al quadro clinico effettua la variazione di dose o incrementa la terapia ancillare. La terapia viene prescritta e validata tramite la firma elettronica del medico sul foglio di terapia antitumorale nella cartella elettronica. Il file nominale validato, viene successivamente trasferito nella cartella condivisa nel settore farmaci e da questo inviato all'UFA. In relazione al tipo di ciclo prescritto, il paziente viene fatto accomodare in sala infusione per procedere al trattamento, oppure invitato a presentarsi il giorno dopo per le infusioni nei casi che richiedono una prescrizione il giorno precedente all'infusione. Terminata l'infusione il paziente viene monitorizzato secondo il protocollo previsto e verificata l'assenza di sintomi, il personale infermieristico rimuove l'accesso venoso e consegna la lettera di dimissioni, che il medico ha completato, validato e stampato. Per i pazienti in cui è prevista la distribuzione di terapie orali la prescrizione sul gestionale Log80 viene recepita dal farmacista, presente in servizio e da lui dispensata. I pazienti che devono fare le terapie orali vengono visitati e gestiti dopo il flusso dei pazienti che effettuano una terapia endovenosa. Successivamente alla conferma e validazione della terapia endovenosa o orale, quando è richiesto viene compilata dal medico la scheda di prescrizione di AIFA ed inviata all'UFA o Settore farmaci. Nella lettera di dimissioni sono inseriti oltre all'anagrafica la diagnosi, le comorbidità, la storia clinica, l'anamnesi oncologica, la terapia somministrata o distribuita, le terapie domiciliari fisse al bisogno e i prossimi appuntamenti Nel corso del trattamento oncologico gli esami richiesti dal medico ematochimici, strumentali e le richieste di visite specialistiche per esigenze cliniche, monitoraggio tossicità e stadiazione della malattia vengono prenotate dal personale amministrativo dedicato al DH. Per i pazienti che effettuano terapia antiHER vengono programmati: eco-cardio trimestrali, per immunoterapie verifica di TSH, cortisolo, ACTH BPN e Troponina, per anticorpi coniugati TC a strato sottile per valutazione polmonite interstiziale. Terminato il percorso di cura, il paziente viene: inviato al GIC con esami di stadiazione e propedeutici alla chirurgia in caso di terapie neoadiuvanti diversamente avviati al follow-up o alla radioterapia. Nel pazienti con malattia metastatica è garantita la presa in carico per la stadiazione, il trattamento farmacologico, il controllo dei sintomi in particolare l'accesso all'ambulatorio di antalgica e la tempestiva transizione alle cure palliative. Per la paziente con malattia metastatica luminale e' previsto un percorso per effettuare la determinazione di mutazioni Pi3K-AKT - PTEN su tessuto, ESR1 su biopsia liquida, PDL su tessuto, ricerca
--	--

	mutazione BRCA 1 e 2 per terapia I pazienti con metastasi ossee candidati a terapia antirassorbitiva vengono inviati alla Dental School per nulla osta ad utilizzo dei farmaci in oggetto. Infine per pazienti metastatici in cui non siano più disponibili trattamenti validati è possibile effettuare una segnalazione al Molecular Tumor Board della Rete Oncologica Viene anche garantito l'accesso al Servizio di Psicologia clinica Organizzazione visite di follow-up ed esami per pazienti affetti da carcinoma della mammella. Fin dalla consegna del referto GIC viene descritto alla paziente un piano di controlli che preveda: la cadenza di visite ed esami, gli operatori coinvolti, le modalità di accesso in caso di emergenze o sospetti di ripresa di malattia. L'ambulatorio di FU viene effettuato prevalentemente dai chirurghi senologici che inviano all'ambulatorio di oncologia in caso di sospetta progressione, tossicità o intolleranza terapia ormonale, valutazione per sospensione o variazione terapia ormonale, sospensione del FU, su richiesta del paziente o del MMG Vengono presi in carico da ambulatorio FU di oncologia invece pazienti ad alto rischio di recidiva o sottoposti a immunoterapia con obiettivo di monitorare effetti tardivi del trattamento immunoterapico Vengono proposti secondo le indicazioni delle linee guida e della rete oncologica i seguenti esami: RX mammografia, eco mammaria e stazione linfonodali annuale, visita clinica e senologica con ematochimici semestrale. In caso di neoplasie triple negative HERpositive e ad alto rischio di recidive vengono prescritti in modalità personalizzata gli esami strumentali. Altresì vengono consigliati controlli densitometrici per pazienti che effettuino terapie ormonali osteopenizzanti e prescritta terapia antirassorbitiva. In casi complessi o di intolleranza il paziente viene inviato all'ambulatorio di Endocrinologia o ad un centro studio osteopatie metaboliche. Sono presenti altresì: ambulatorio di Dietologia con medico specialista in Scienza dell'alimentazione e dietista. ambulatorio di antalgica ambulatorio agopuntura È attivo altresì; ambulatorio di Fisiatria con servizio di FKT che valuta e prende in carico tutte le pazienti sottoposte a mastectomia o DA e tutte quelle che abbiano problemi riabilitativi correlati con il percorso
--	---

	Infine in qualsiasi parte del percorso è possibile su segnalazione di un operatore attivare il Percorso protezione famiglie Fragili della Rete Oncologica I volontari delle associazioni accreditate in ospedale (AVC e CasaBreast) sono presenti presso la struttura del DH Oncologico, per il supporto durante le attese tra un passaggio e l'altro nel percorso giornaliero, contribuiscono e sono di sostegno nel percorso personale delle pazienti. LETTERATURA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO • Linee guida dell'Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), versione 2023 disponibile sul sito www.aiom.it • http://dati.istat.it/ • Linee Guida ESMO EARLY BC e METASTATIC BC 2024 e 2025 • Regione Piemonte, DGR 23/1/2015, n. 1-924 Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale" (BURP 4S2 29/01/2015) • Biganzoli L, Cardoso F, Beishon M, et al. The requirements of a specialist breast centre . The Breast 2020, 51:65-84 • D.G.R. Piemonte n. 71-7681 del 29 marzo 2019 • D.G.R. Piemonte 9-3819 del 24.09.2021: “Decreto del Ministero della Salute, 18 maggio 2021, inerente a Modalità di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce”
--	--

Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili

Specifico per patologia

Descrizione del bacino di utenza	<i>Torino e provincia</i>
Numero di abitanti del bacino di utenza	
Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza	
Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza (GIC di riferimento)	

Neoplasie di pertinenza del GIC

Neoplasia
Carcinoma della mammella in fase iniziale EBC operabile
Carcinoma della mammella localmente avanzato non operabile
Carcinoma della mammella in ricaduta locale
Carcinoma della mammella in fase avanzata metastatica ABC

Segnalare con A (assistenziale) nelle diverse descrizioni sintetiche, eventuali specificità assistenziali

Descrizione sintetica dell'iter diagnostico

Secondo le LG AIOM 2023

Per le procedure di I livello già presenti nel PDTA CAS (laboratorio, radiologia ecc) non ripetere l'inserimento.

Indicare solo le procedure considerate essenziali e le modalità di accesso. Nella colonna "condizione" è possibile ma non necessario specificare lo stadio o le caratteristiche del paziente in cui la procedura viene richiesta. Nella colonna "modalità di accesso" vanno indicate la sede in cui si effettua la procedura e le modalità di prenotazione (telefonica, richiesta cartacea, ecc.). Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia.

Condizione	Procedure	Modalità di accesso	Tempi previsti di accesso
Sospetto o diagnosi di carcinoma della mammella (in tutti i casi)	Mammografia / Ecografia mammaria linfonodale / Visita radiologica	Senologia Diagnostica -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC	1 settimana
	Agobiopsia mammaria o linfonodale su guida ecografica	Senologia Diagnostica -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione diretta o da parte del CAS / GIC	ENTRO 72 H
	Biopsia mammaria con guida mammografica su area di microcalcificazioni sospette o distorsione sospetta	Senologia Diagnostica -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC	ENTRO 72 H
	Risonanza Magnetica della mammella bilaterale con mdc (stadiazione locale in prima diagnosi, valutazione della risposta al trattamento neoadiuvante)	Radiologia Poliambulatorio Statuto o ospedale Koelliker -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte della Senologia Diagnostica, del CAS, del GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	1-2 settimana
	Mammografia con mdc (stadiazione locale in prima diagnosi, valutazione della risposta al trattamento neoadiuvante)	Senologia Diagnostica -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC	1-2 settimana
	Esame istologico	Anatomia Patologica Presidio -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione diretta dalla Senologia	1 settimana

		diagnostica o da parte del CAS / GIC	
	Tipizzazione fenotipica con determinazione fattori prognostici e predittivi (ER PgR HER2 Ki67) in pazienti candidabili a terapia neoadiuvante / primaria	Anatomia Patologica Presidio -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione diretta dalla Senologia diagnostica o da parte del CAS / GIC	2 settimane
	Analisi citogenetiche per pazienti candidate a terapia neoadiuvante o su pezzo operatorio (es. FISH per HER2)	Anatomia Patologica Città della Salute -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione diretta dalla Senologia diagnostica o da parte del CAS / GIC	3 settimane
	Determinazione PDL1 in caso di malattia avanzata triple negative	Anatomia Patologica Città della Salute -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione diretta parte del SC Oncologia	2 settimane
	NGS su tessuto per determinazione mutazione PTEN-AKT-PTEN per malattia avanzata luminale dopo inibitore cicline	Anatomia Patologica Città della Salute/Osp S Luigi -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione diretta dalla m DH SC Oncologia	2 settimane
	Biopsia liquida per ricerca mutazione ESR1 per malattia avanzata luminale	Anatomia Patologica Città della Salute/Osp S Luigi -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione diretta dal DH SC Oncologia	2 settimane
Carcinoma della mammella in età ≤ 38 aa	Counselling riproduttivo	-Osp Sant'Anna FERTISAVE - Osp. Valdese	1 settimana

	Profilassi della funzionalità ovarica con LHRH Analogo mensile	-impegnativa DEMA del M di MG di visita ginecologica e ecografia TV -Prenotazione diretta tra specialisti o da parte del CAS / GIC o della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche SC Oncologia -Impegnativa interna da parte del CAS / GIC o della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	
Carcinoma della mammella in età ≥ 75 aa e G8 <14 ≥ 85 aa	Visita collegiale oncogeriatrica	SC Oncologia (oncologo + geriatra) DEMA MMG	1-2 settimane
Carcinoma della mammella non palpabile candidato a chirurgia	Posizionamento di repere su guida ecografica o mammografica con cartella prericovero	Senologia Diagnostica -Impegnativa interna con apertura cartella -Prenotazione da parte del CAS / GIC	2-4 settimane
Carcinoma della mammella candidato a terapia neoadiuvante	Posizionamento di repere su guida ecografica	Senologia Diagnostica -Impegnativa interna con apertura cartella DS -Prenotazione da parte del CAS / GIC	1 settimana
Carcinoma della mammella operabile, ad elevato rischio di secondarietà – in presenza di sintomatologia sospetta - se candidato a terapia neoadiuvante / primaria - stadio III o IV	In casi selezionati Rx torace Ecografia addome completo	SC Radiologia - Imp DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC	1 settimana

	Scintigrafia ossea totale corporea	Medicina Nucleare Ospedale Mauriziano -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS, del GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	2-4 settimane
	TC oncologica di stadiazione con mdc	SC Radiologia -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	1-2 settimane
In casi selezionati es.: mastite carcinomatosa, ca infiammatorio, o come esame di II livello di approfondimento in casi non dirimenti agli esami standard	PET-TC totale corporea	Medicina Nucleare IRMET Affidea Osp Mauriziano IRCC Candiolo -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS, del GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	1-3 settimane
In pazienti elegibili a CT adiuvante neoadiuvante primaria di I linea	Ecocardiogramma +/- visita cardiologica	SC Radiologia -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	1-2 settimane
	Visita anestesiologicala e posizionamento CVC	Day Surgery -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	10 gg

Descrizione sintetica dei trattamenti

I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM. Sono indicate solo le procedure considerate essenziali e le modalità di accesso.

Condizione	Procedure	Modalità di accesso	Tempi previsti di accesso
Carcinoma della mammella operabile	Intervento chirurgico conservativo, biopsia del linfonodo sentinella / dissezione ascellare	Visita senologica CAS: chirurgica senologica Discussione GIC	SC Chirurgia 4 settimane dalla visita
	Mastectomia con biopsia del linfonodo sentinella / dissezione ascellare	Visita senologica CAS: chirurgica senologica Discussione GIC	SC Chirurgia 4 settimane dalla visita
	Mastectomia con ricostruzione mammaria immediata	Visita senologica CAS + I visita chirurgica plastica	SC Chirurgia 4 settimane dalla visita
	Ricostruzione mammaria differita	Visita chirurgica plastica	SC Chirurgia 6 mesi
	Terapia medica adiuvante	Visita GIC post-operatoria con impostazione iter terapeutico Successiva I visita oncologica con visione esami richiesti e acquisizione consenso	Ambulatorio Terapie Oncologiche 4-6 settimane dalla chirurgia
	Radioterapia postoperatoria adiuvante	Visita GIC post-operatoria	SC Radioterapia SGAS 6 settimane Entro 12 settimane dalla chirurgia
Carcinoma della mammella candidato a terapia pre-chirurgica	Chemioterapia +/- terapia biologica Chemioterapia =	Visita GIC pre-terapia con impostazione iter terapeutico Successiva I visita oncologica con visione esami richiesti e acquisizione consenso Attento	Ambulatorio Terapie oncologiche 3 settimane dal sospetto clinico 2 settimane dal GIC

		monitoraggio clinico in corso Stima del termine del trattamento	
Carcinoma della mammella metastatico	Chemioterapia +/- agenti biologici Endocrinoterapia +/- agenti biologici Terapie coadiuvanti (es antiriassorbitivi)	Visita GIC mammella o visita CAS oncologica con impostazione iter terapeutico	Ambulatorio Terapie oncologiche 3 settimane dal sospetto clinico

Follow up

Secondo linee guida AIOM, procedure finalizzate alla diagnosi di ripresa di malattia ma anche gli interventi utili alla riabilitazione, al controllo delle tossicità tardive e all'educazione alla salute.

Procedura	Periodicità	Dove viene svolta
<i>Esame clinico Rilievo parametri antropometrici: peso, altezza, BMI,</i>	Per 5 aa dalla chirurgia: ogni 6 mesi Dal 5° al 10° aa: annuale se endocrinoterapia protratta oltre il 5° o 10° anno, al termine dei trattamenti adiuvanti, invio al Curante di MG	<i>Ambulatori di follow up (alternanza tra oncologi, chirurghi senologi, radioterapisti) fino al 5°- 10° anno poi MMG</i>
<i>Mammografia ecografia mammaria cavi ascellari e visita radiologica</i>	annuale	<i>Senologia diagnostica</i>
<i>Visita ginecologica + ecografia pelvica TV</i>	annuale	
<i>Osteodensitometria DXA lombare e/o femorale</i>	Ogni 18-24 mesi se in trattamento con LHRH Analoghi e/o IA	
<i>Ematochimici crasi ematica indici di funzionalità epatica e renale 25OH vit D</i>	Annuale o sec necessità	Laboratorio Analisi interno o altra sede

<i>FSH Estradiolo</i>		
<i>Profilo lipidico e glicemia</i>	Annuale in pazienti in trattamento con IA	Laboratorio Analisi interno o altra sede
<i>Ecocardiogramma</i>	annuale in pazienti esposti a CT (antracicline e agenti anti-HER2)	Servizio di Cardiologia
<i>Ulteriori esami strumentali</i>	Sulla scorta di sintomatologia clinica	Radiologia

Altre procedure correlate al follow up

Consegna lettera informativa per il curante con le indicazioni sulle procedure indicate	<i>SI/NO (se si fornire in allegato)</i>
Consegna lettera informativa per il paziente all'inizio e/o al termine del follow up specialistico	<i>SI/NO (se si fornire in allegato)</i>
Consegna della programmazione del follow up	<i>SI/NO (se si fornire in allegato)</i>
Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro specialistico	<i>SI accesso mediante CAS visita senologica radiologica / chirurgica / oncologica / urgente</i>

Condizione	Procedure	Modalità di accesso	Tempi previsti di accesso
Sospetto o diagnosi di carcinoma della mammella (in tutti i casi)	Mammografia / Ecografia mammaria linfonodale / Visita radiologica	Senologia Diagnostica -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC	1 settimana
	Agobiopsia mammaria o linfonodale su guida ecografica	Senologia Diagnostica -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione diretta o da parte del CAS / GIC	ENTRO 72 H
	Biopsia mammaria con guida mammografica su area di microcalcificazioni sospette o distorsione sospetta	Senologia Diagnostica -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC	ENTRO 72 H
	Risonanza Magnetica della mammella bilaterale con mdc (stadiazione locale in prima diagnosi, valutazione della risposta al trattamento neoadiuvante)	Radiologia Poliambulatorio Statuto o ospedale Koelliker -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte della Senologia Diagnostica, del CAS, del GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	1-2 settimana
	Mammografia con mdc (stadiazione locale in prima diagnosi, valutazione della risposta al trattamento neoadiuvante)	Senologia Diagnostica -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC	1-2 settimana
	Esame istologico	Anatomia Patologica Presidio Cottolengo -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione diretta dalla Senologia diagnostica o da parte del CAS / GIC	1 settimana
	Tipizzazione fenotipica con determinazione fattori prognostici e predittivi (ER PgR HER2 Ki67) in pazienti candidabili a terapia neoadiuvante / primaria	Anatomia Patologica presidio -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione diretta dalla Senologia diagnostica o da parte del CAS / GIC	2 settimane

	Analisi citogenetiche per pazienti candidate a terapia neoadiuvante o su pezzo operatorio (es. FISH per HER2)	Anatomia Patologica Città della Salute -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione diretta dalla Senologia diagnostica o da parte del CAS / GIC	3 settimane
Carcinoma della mammella in età ≤ 38 aa	Counselling riproduttivo Profilassi della funzionalità ovarica con LHRH Analogo mensile	Ginecologia Osp -Sant'AnnaFERTISAVE - Osp. Valdese -impegnativa DEMA del M di MG di visita ginecologica e ecografia TV -Prenotazione diretta tra specialisti o da parte del CAS / GIC o della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche SC Oncologia -Impegnativa interna da parte del CAS / GIC o della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	1 settimana
Carcinoma della mammella in età ≥ 75 aa e G8 <14 ≥ 85 aa	Visita collegiale oncogeriatrica	SC Oncologia (oncologo + geriatra) -impegnativa interna da parte del CAS / GIC	1-2 settimane
Carcinoma della mammella non palpabile candidato a chirurgia	Posizionamento di repere su guida ecografica o mammografica con cartella prericovero	Senologia Diagnostica -Impegnativa interna con apertura cartella -Prenotazione da parte del CAS / GIC	2-4 settimane
Carcinoma della mammella candidato a terapia neoadiuvante	Posizionamento di repere su guida ecografica	Senologia Diagnostica -Impegnativa interna con apertura cartella DS -Prenotazione da parte del CAS / GIC	1 settimana
Carcinoma della mammella operabile, ad	In casi selezionati Rx torace Ecografia addome completo	SC Radiologia -Impegnativa interna o DEMA del M di MG	1-2 settimane

elevato rischio di secondarietà – in presenza di sintomatologia sospetta - se candidato a terapia neoadiuvante / primaria - stadio III o IV		-Prenotazione da parte del CAS / GIC	
	Scintigrafia ossea totale corporea	Medicina Nucleare Ospedale Mauriziano -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS, del GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	2-4 settimane
	TC oncologica di stadiazione con mdc	SC Radiologia -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	1-2 settimane
In casi selezionati es.: mastite carcinomatosa, ca infiammatorio, o come esame di II livello di approfondimento in casi non dirimenti agli esami standard	PET-TC totale corporea	Medicina Nucleare IRMET Affidea -Impegnativa DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS, del GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	1-3 settimane
In pazienti elegibili a CT adiuvante neoadiuvante primaria di I linea	Ecocardiogramma +/- visita cardiologica	SC Radiologia -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	
	Visita anestesilogica e posizionamento CVC	Day Surgery -Impegnativa interna o DEMA del M di MG -Prenotazione da parte del CAS / GIC, della Segreteria Ambulatorio Terapie Oncologiche	

Descrizione sintetica dei trattamenti

I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM. Sono indicate solo le procedure considerate essenziali e le modalità di accesso.

Condizione	Procedure	Modalità di accesso	Tempi previsti di accesso
Carcinoma della mammella operabile	Intervento chirurgico conservativo, biopsia del linfonodo sentinella / dissezione ascellare	Visita senologica CAS: chirurgica senologica Discussione GIC	SC Chirurgia 4 settimane dalla visita
	Mastectomia con biopsia del linfonodo sentinella / dissezione ascellare	Visita senologica CAS: chirurgica senologica Discussione GIC	SC Chirurgia 4 settimane dalla visita
	Mastectomia con ricostruzione mammaria immediata	Visita senologica CAS + I visita chirurgica plastica	SC Chirurgia 4 settimane dalla visita
	Ricostruzione mammaria differita	Visita chirurgica plastica	SC Chirurgia 6mesi
	Terapia medica adiuvante	Visita GIC post-operatoria con impostazione iter terapeutico Successiva I visita oncologica con visione esami richiesti e acquisizione consenso	Ambulatorio Terapie Oncologiche 4-6 settimane dalla chirurgia
	Radioterapia postoperatoria adiuvante	Visita GIC post-operatoria	SC Radioterapia SGAS 6 settimane Entro 16 settimane dalla chirurgia
Carcinoma della mammella candidato a terapia pre-chirurgica	Chemioterapia +/- terapia biologica Chemioterapia =	Visita GIC pre-terapia con impostazione iter terapeutico Successiva I visita oncologica con visione esami richiesti e acquisizione consenso Attento monitoraggio clinico in corso Stima del termine del trattamento	Ambulatorio Terapie oncologiche 3 settimane dal sospetto clinico 2 settimane dal GIC
Carcinoma della mammella metastatico	Chemioterapia +/- agenti biologici Endocrinoterapia (a prescrizione ospedaliera) +/- agenti biologici Terapie coadiuvanti (es antiriassorbitivi)	Visita GIC mammella o visita CAS oncologica con impostazione iter terapeutico	Ambulatorio Terapie oncologiche 3 settimane dal sospetto clinico

Follow up

Secondo linee guida AIOM, procedure finalizzate alla diagnosi di ripresa di malattia ma anche gli interventi utili alla riabilitazione, al controllo delle tossicità tardive e all'educazione alla salute.

Procedura	Periodicità	Dove viene svolta
Esame clinico Rilievo parametri antropometrici: peso, altezza, BMI,	Per 5 aa dalla chirurgia: ogni 6 mesi Dal 5° al 10° aa: annuale se endocrinoterapia protratta oltre il 5° o 10° anno, al termine dei trattamenti adiuvanti, invio al Curante di MG	Ambulatori di follow up (alternanza tra oncologi, chirurghi senologi, radioterapisti) fino al 5°- 10° anno poi MMG
Mammografia ecografia mammaria cavi ascellari e visita radiologica	annuale	Senologia diagnostica
Visita ginecologica + ecografia pelvica TV	annuale	
Osteodensitometria DXA lombare e/o femorale	Ogni 18-24 mesi se in trattamento con LHRH Analoghi e/o IA	
Ematochimici crasi ematica indici di funzionalità epatica e renale 25OH vit D FSH Estradiolo	Annuale o sec necessità	Laboratorio Analisi interno o altra sede
Profilo lipidico e glicemia	Annuale in pazienti in trattamento con IA	Laboratorio Analisi interno o altra sede
Ecocardiogramma	annuale in pazienti esposti a CT (antracicline e agenti anti-HER2)	Servizio di Cardiologia
Ulteriori esami strumentali	Sulla scorta di sintomatologia clinica	Radiologia

Altre procedure correlate al follow up

Consegna lettera informativa per il curante con le indicazioni sulle procedure indicate	SI/NO (se si fornire in allegato)
Consegna lettera informativa per il paziente all'inizio e/o al termine del follow up specialistico	SI/NO (se si fornire in allegato)
Consegna della programmazione del follow up	SI/NO (se si fornire in allegato)
Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro specialistico	SI accesso mediante CAS visita senologica radiologica / chirurgica / oncologica / urgente